BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Quy trình phòng ngừa té ngã người bệnh

Bản cập nhật theo đề cương Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023

Bản trình thẩm định — rà soát ngày 13/10/2026. Hoạt động phòng ngừa được cá thể hóa theo yếu tố nguy cơ, khả năng di chuyển và nhu cầu hỗ trợ; điểm số không thay thế nhận định lâm sàng.

Thông tin	Nội dung
Mã quy trình	SOP-QLCL-ATNB-01 — mã trong file nguồn, bệnh viện xác nhận
Phiên bản	1.1 — bản đề xuất cập nhật từ phiên bản 1.0
Ngày ban hành và hiệu lực	……
Khoa phòng áp dụng	Các khoa, phòng, khu khám và khu vực phục vụ người bệnh
Người soạn	……
Người kiểm tra và thẩm định	……
Người phê duyệt	Giám đốc hoặc người có thẩm quyền: ……
Văn bản ban hành	Số: ……; ngày: ……

Các mốc thời gian nội bộ, màu hoặc ký hiệu cảnh báo, ngưỡng Morse và cách tổ chức giám sát cần được bệnh viện phê duyệt trước sử dụng. File nguồn được giữ nguyên. Chưa xác nhận quy trình đã được ban hành hoặc triển khai.

Nội dung tài liệu

1 Đại cương
2 Chỉ định
3 Chống chỉ định
4 Thận trọng
5 Chuẩn bị với các mục 5.1 đến 5.9
6 Tiến hành quy trình
7 Theo dõi và xử trí tai biến
Tài liệu tham khảo
Phụ lục 1 Danh mục nguồn lực
Phụ lục 2 Phiếu nhận định và kế hoạch phòng ngừa
Phụ lục 3 Morse khi được bệnh viện phê duyệt
Phụ lục 4 Theo dõi và bàn giao
Phụ lục 5 Ghi nhận sau té ngã
Phụ lục 6 Bảng kiểm giám sát
Phụ lục 7 Chỉ số và lưu đồ

1 Đại cương

Té ngã là sự kiện người bệnh ngoài ý muốn rơi hoặc ngã xuống sàn hay một bề mặt thấp hơn. Trường hợp được nhân viên đỡ nhưng vẫn hạ xuống bề mặt thấp hơn được ghi nhận là té ngã có hỗ trợ. Tình huống mất thăng bằng được ngăn chặn trước khi xảy ra té ngã được theo dõi riêng như tình huống suýt xảy ra; không gộp vào tử số tỷ lệ té ngã.

Mục đích là giảm số lần ngã và tổn thương do ngã bằng nhận định, xử lý yếu tố nguy cơ và hỗ trợ đúng nhu cầu. Các yếu tố liên quan gồm bệnh lý, thuốc, tri giác, khả năng di chuyển, thị giác, nhu cầu bài tiết và môi trường. Mọi người bệnh đều được áp dụng biện pháp an toàn cơ bản; người có yếu tố đáng lo được hỗ trợ tăng cường dù điểm số thấp.

Quy trình áp dụng toàn bệnh viện, gồm nội trú, ngoại trú, cấp cứu, khu thủ thuật, vận chuyển và các khu vực người bệnh sử dụng. Nội dung được sắp theo 7 phần QĐ 3023; phần nguồn lực và thời lượng được mô tả phù hợp hoạt động phòng ngừa liên tục. Hướng dẫn xử trí chấn thương, cấp cứu và kỹ thuật di chuyển cụ thể được thực hiện theo quy trình chuyên môn riêng của bệnh viện.

Căn cứ chính: Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; Thông tư 19/2013/TT-BYT về quản lý chất lượng; Bộ tiêu chí theo QĐ 6858/QĐ-BYT, đặc biệt D2.5; Thông tư 43/2018/TT-BYT về phòng ngừa sự cố y khoa, áp dụng các nội dung còn hiệu lực; QĐ 3023/QĐ-BYT về đề cương và thể thức. Nguồn chuyên môn quốc tế được dùng để tham khảo, không coi là quy định pháp luật Việt Nam. Không dùng quy tắc ứng xử hoặc nhãn JCI chung chung làm căn cứ cho ngưỡng Morse.

2 Chỉ định

Thực hiện an toàn môi trường và hướng dẫn phòng ngừa cho tất cả người bệnh. Nhận định có hệ thống khi tiếp nhận nội trú; tại ngoại trú và cấp cứu, nhận diện nhu cầu hỗ trợ ngay khi người bệnh đến hoặc trước di chuyển. Đánh giá đầy đủ hơn khi có tiền sử ngã, đi không vững, chóng mặt, ngất, hạn chế vận động, tri giác thay đổi, thuốc có nguy cơ hoặc bất kỳ lo ngại lâm sàng nào.

Người cao tuổi, người bệnh suy yếu, sau gây mê hoặc an thần, sau phẫu thuật, bệnh thần kinh và người có nhu cầu đi vệ sinh thường xuyên cần chú ý hỗ trợ. Với người từ 65 tuổi và người 50–64 tuổi có yếu tố nguy cơ trong viện, tham khảo NICE NG249 để tổ chức đánh giá toàn diện; đây là phạm vi của hướng dẫn quốc tế, không phải ngưỡng pháp lý áp dụng cho mọi nhóm tuổi.

Trẻ em, sản phụ và các nhóm chuyên khoa áp dụng nhận định phù hợp lứa tuổi, tình trạng và quy trình đã duyệt. Không mặc nhiên dùng Morse người lớn để phân loại trẻ em hoặc suy ra mọi trẻ em đều cùng mức nguy cơ.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định chung với hoạt động phòng ngừa té ngã và nhận diện nguy cơ. Chống chỉ định của từng thao tác vận động hoặc đánh giá tư thế phải được xét riêng: không yêu cầu người bệnh đứng, đi hoặc đổi tư thế để thử thang điểm nếu chưa an toàn, có chỉ định bất động, không ổn định hoặc nghi chấn thương. Trường hợp không thể đánh giá một yếu tố, ghi lý do và xử trí theo nhận định; không mặc định điểm 0.

4 Thận trọng

Điểm 0 không có nghĩa không thể té ngã. NICE NG249 năm 2025 khuyến cáo không dùng công cụ dự đoán để dự đoán khả năng ngã trong nhóm đối tượng của hướng dẫn. Nếu bệnh viện tiếp tục dùng Morse, sử dụng như công cụ bổ trợ nhận diện yếu tố, kèm đánh giá toàn diện và kế hoạch; không phân bổ chăm sóc chỉ theo điểm.

Thanh chắn giường cần đánh giá riêng theo tri giác, hành vi, khả năng vận động và độ tương thích giường, nệm. Không mặc định nâng toàn bộ thanh chắn hoặc dùng phương tiện cố định chỉ để phòng ngã; có nguy cơ mắc kẹt và ngã khi trèo qua. Thực hiện theo hướng dẫn nhà sản xuất và quy định của bệnh viện, ghi lý do và đánh giá lại.

Chuông báo rời giường và ký hiệu cảnh báo chỉ hỗ trợ giao tiếp và phát hiện; không thay nhân viên quan sát, hỗ trợ. Không để người nhà là biện pháp duy nhất khi người bệnh cần nhân viên chuyên môn trợ giúp.

Không hạn chế vận động không cần thiết. Chọn cách di chuyển và mức hỗ trợ phù hợp để duy trì chức năng; các chỉ định bất động được tuân thủ. Không tự ngừng hoặc giảm thuốc, tự kê an thần để giữ người bệnh nằm giường.

Sau té ngã, không kéo hoặc dựng người bệnh dậy ngay. Ưu tiên đánh giá cấp cứu và chấn thương; có thể cần di chuyển khẩn nếu hiện trường nguy hiểm hoặc để thực hiện can thiệp cứu sống. Người dùng thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc có rối loạn đông máu cần báo bác sĩ khi có hoặc nghi chấn thương đầu.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Vai trò	Trách nhiệm
Điều dưỡng và hộ sinh	Nhận định, lập kế hoạch, hỗ trợ, đánh giá lại, ghi hồ sơ, bàn giao và báo cáo.
Bác sĩ	Đánh giá nguyên nhân bệnh lý, thuốc và chấn thương; chỉ định điều trị, theo dõi, hội chẩn hoặc chuyển tuyến.
Điều dưỡng trưởng khoa	Phân công người hỗ trợ theo ca; kiểm tra môi trường, phương tiện và tuân thủ; bố trí nguồn lực.
Phòng Điều dưỡng	Đào tạo, hướng dẫn công cụ, giám sát, tổng hợp chỉ số và cập nhật quy trình.
Quản lý chất lượng	Tiếp nhận, phân loại và quản lý sự cố; xác định nghĩa vụ báo cáo theo nội dung pháp luật còn hiệu lực; phối hợp phân tích và cải tiến.

Vai trò	Trách nhiệm
Dược phục hồi chức năng và đơn vị hỗ trợ	Rà soát thuốc, đánh giá và hỗ trợ vận động theo chức năng; bảo trì, vệ sinh và khắc phục môi trường.
Người bệnh và người chăm sóc	Phối hợp hướng dẫn, báo nhu cầu và triệu chứng, gọi trợ giúp; không thay trách nhiệm chăm sóc của nhân viên.

Người hỗ trợ trực tiếp và số nhân viên khi chuyển tư thế được xác định theo khả năng người bệnh, phương tiện và kỹ thuật di chuyển đã được đào tạo. Khi thiếu nhân lực hoặc thiết bị, báo điều dưỡng trưởng và bố trí hỗ trợ trước khi thực hiện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc dùng thường quy để thực hiện phòng ngừa té ngã. Thu thập danh sách thuốc hiện dùng, thời điểm và thay đổi gần đây; báo bác sĩ hoặc dược lâm sàng khi có biểu hiện ảnh hưởng vận động, tỉnh táo hoặc huyết áp. Thuốc điều trị sau ngã chỉ thực hiện theo chỉ định và quy trình sử dụng thuốc; ghi đúng tên, hàm lượng hoặc nồng độ, liều, đường và thời điểm dùng.

5.3 Vật tư

Phương tiện cảnh báo theo quy ước bệnh viện; đồ dùng cá nhân và giày dép vừa chân, chống trượt phù hợp; phương tiện hỗ trợ bài tiết nếu cần. Vật tư cấp cứu và phòng hộ được chuẩn bị theo tình huống, quy trình liên quan. Phiếu giấy hoặc biểu mẫu điện tử thuộc hồ sơ, không tính là vật tư trực tiếp của kỹ thuật.

5.4 Trang thiết bị

Giường hoặc băng ca, xe lăn với phanh hoạt động; chuông gọi dễ sử dụng; dụng cụ hỗ trợ đi lại phù hợp; máy đo huyết áp và thiết bị theo dõi khi có chỉ định. Đánh giá độ tương thích giường, nệm, thanh chắn và phương tiện trợ giúp. Dụng cụ nâng, chuyển người bệnh chỉ dùng khi có sẵn, phù hợp và nhân viên được đào tạo. Đội cấp cứu có phương tiện theo quy trình bệnh viện.

5.5 Người bệnh

Giải thích nguy cơ cá nhân và cách gọi trợ giúp bằng ngôn ngữ dễ hiểu; kiểm tra người bệnh có thể thao tác chuông gọi và nhắc lại hướng dẫn. Đánh giá tri giác, đau, nhu cầu bài tiết, khả năng tự chăm sóc, vận động, giày dép và dụng cụ đang dùng. Với người hạn chế giao tiếp, bố trí cách gọi phù hợp và trao đổi với người chăm sóc.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Có phiếu nhận định, kế hoạch chăm sóc, thông tin dị ứng, thuốc, chỉ định vận động và các lần đánh giá trước. Chuẩn bị thông tin bàn giao, biểu mẫu theo dõi và ghi nhận sự cố. Dùng mẫu được bệnh viện phê duyệt; tích hợp vào hồ sơ sẵn có để tránh ghi trùng và bảo vệ thông tin cá nhân.

5.7 Thời gian thực hiện

Nhận định ban đầu và lập kế hoạch: dự kiến 0,08–0,17 giờ cho một người bệnh thông thường; đây là ước tính để bệnh viện thẩm định, không phải định mức của QĐ 3023. Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian. Các biện pháp phòng ngừa được duy trì trong suốt thời gian người bệnh thuộc phạm vi chăm sóc; ghi rõ thời điểm đánh giá lại và mức hỗ trợ theo từng ca.

5.8 Địa điểm thực hiện

Tại giường, khu khám, phòng thủ thuật, nhà vệ sinh, hành lang và khi vận chuyển. Chọn vị trí đủ không gian, riêng tư và an toàn; không thử đi lại ở nơi trơn trượt hoặc không có người hỗ trợ khi cần.

5.9 Kiểm tra hồ sơ

a) Xác minh đúng người bệnh theo quy định; đối chiếu tình trạng, chỉ định vận động, thuốc và yếu tố nguy cơ. Không dùng số giường làm định danh duy nhất.

b) Kiểm tra bảng kiểm an toàn: môi trường, phanh, chuông gọi, dụng cụ, số người hỗ trợ và cảnh báo phù hợp. Nếu thiếu điều kiện an toàn, khắc phục hoặc báo để bổ sung trước di chuyển.

c) Xác định tư thế và phương án di chuyển: dựa trên chỉ định, khả năng chịu lực và tình trạng; chưa đánh giá an toàn thì không cho tự đứng hoặc đi để hoàn tất phiếu.

6 Tiến hành quy trình

6.1 Bước 1 Tiếp nhận và nhận diện nguy cơ

Nhận định trước lần di chuyển đầu khi có nhu cầu trợ giúp. Khai thác ngã trước đây và hoàn cảnh, chóng mặt hoặc ngất; quan sát tri giác, vận động và khả năng hiểu hướng dẫn. Kiểm tra thuốc, bệnh lý, đau, bài tiết, thị giác hoặc thính giác, dây truyền và môi trường. Bác sĩ đánh giá nguyên nhân bệnh lý nếu có; không chỉ tick một ô tuổi cao.

Đề xuất lịch nội bộ: nhận định khi tiếp nhận; rà soát mỗi ca nội trú; đánh giá lại ngay khi chuyển khoa, thay đổi tình trạng hoặc thuốc gây ảnh hưởng, sau gây mê hoặc thủ thuật trước lần vận động đầu, sau ngã hoặc suýt ngã. Tần suất cuối cùng phải được phê duyệt và có thể tăng theo nhu cầu; không đợi đến ca kế tiếp khi có thay đổi rõ.

6.2 Bước 2 Xác định nhu cầu hỗ trợ và lập kế hoạch

Ghi rõ người bệnh được tự di chuyển trong điều kiện nào, cần giám sát, một hoặc nhiều người hỗ trợ, dụng cụ gì, lịch đáp ứng bài tiết và người phụ trách. Có thể cần tăng hỗ trợ ngay vì đi không vững, lú lẫn, ngất, hậu an thần hoặc ngã gần đây dù Morse chưa cao. Thang điểm bổ trợ chỉ dùng đúng nhóm đối tượng và bản được phê duyệt; xem Phụ lục 3.

Phân biệt nguy cơ xảy ra ngã với nguy cơ tổn thương nặng khi ngã như loãng xương, chống đông hoặc bệnh dễ chảy máu. Kế hoạch hỗ trợ phải xử lý từng yếu tố đã nhận định; ký hiệu cảnh báo không thay một kế hoạch cụ thể.

6.3 Bước 3 Thực hiện biện pháp chung

Nội dung	Cách thực hiện và kiểm tra
Môi trường	Giữ sàn khô; xử lý tràn đổ ngay và có cảnh báo trong khi khắc phục. Lối đi thoáng, đủ ánh sáng, phòng vệ sinh có phương tiện hỗ trợ phù hợp.
Giường và phương tiện	Vị trí giường an toàn phù hợp khi nghỉ; khóa phanh khi cần. Xe lăn hoặc băng ca được kiểm tra trước chuyển; không để người bệnh ngồi trên phương tiện không ổn định.
Gọi và lấy đồ	Chuông gọi, nước và vật dụng thiết yếu trong tầm với; kiểm tra người bệnh sử dụng được. Bố trí cách gọi khác nếu không dùng được chuông.
Giày dép và trợ cụ	Giày dép vừa chân, phù hợp chống trượt; dụng cụ hỗ trợ đúng loại, kích thước và cách dùng.
Hướng dẫn	Dặn gọi trợ giúp theo kế hoạch, báo chóng mặt, đau và nhu cầu vệ sinh; giải thích cách di chuyển an toàn và kiểm tra người bệnh hiểu.

6.4 Bước 4 Hỗ trợ tăng cường theo nguy cơ

Yếu tố	Biện pháp cá thể hóa
Đi không vững hoặc yếu liệt	Chọn mức trợ giúp và trợ cụ; phối hợp phục hồi chức năng khi cần; không giao người bệnh tự đi nếu chưa an toàn.
Chóng mặt hoặc liên quan tư thế	Trợ giúp đổi tư thế theo khả năng, theo dõi triệu chứng và báo bác sĩ; kiểm tra huyết áp theo chỉ định. Không ép đứng để lấy đủ điểm.
Nhu cầu bài tiết	Chủ động hỏi và bố trí hỗ trợ đến nhà vệ sinh hoặc phương tiện tại giường; không để người bệnh phải chờ đến mức tự rời giường nguy hiểm.
Lú lẫn hoặc sau an thần	Đánh giá nguyên nhân và mức tỉnh táo; tăng quan sát có phân công; điều chỉnh môi trường, giải thích lặp lại. Chưa hồi phục thì hỗ trợ vận động theo quy trình liên quan.
Thuốc hoặc bệnh lý liên quan	Báo bác sĩ, phối hợp dược; can thiệp điều trị theo chỉ định, không tự đổi liều.

Yếu tố	Biện pháp cá thể hóa
Nhận diện và giám sát	Cảnh báo theo quy ước có bảo mật; bố trí vị trí thuận lợi quan sát khi phù hợp. Nếu dùng thiết bị báo động, kiểm tra hoạt động và người đáp ứng.

Thanh chắn được đánh giá về lợi ích và nguy cơ mắc kẹt, trèo qua; không thay quan sát. Bố trí người hỗ trợ thực tế trong ca và có phương án khi người chăm sóc vắng. Bệnh viện xác nhận ký hiệu và màu cảnh báo thống nhất, không tự chọn màu như yêu cầu bắt buộc.

6.5 Bước 5 Đánh giá lại và bàn giao

Kiểm tra biện pháp đã thực hiện, mức hỗ trợ có phù hợp và đáp ứng người bệnh. Cập nhật ngay khi diễn biến thay đổi; ghi điểm mới nếu dùng công cụ và ghi nhận định ngoài thang. Bàn giao ISBAR về nguyên nhân nguy cơ, khả năng di chuyển, thuốc liên quan, lần ngã, biện pháp, việc cần theo dõi và người nhận trách nhiệm.

6.6 Bước 6 Khi xảy ra té ngã

Gọi hỗ trợ và bác sĩ hoặc đội cấp cứu tùy tình trạng; ở lại với người bệnh, bảo đảm hiện trường an toàn. Đánh giá ban đầu theo ABCDE và tình trạng chấn thương. Nếu ngừng tuần hoàn, kích hoạt quy trình hồi sinh ngay; không chờ bác sĩ đến mới bắt đầu can thiệp trong phạm vi được đào tạo. Xem mục 7 và quy trình cấp cứu bệnh viện.

Không tự dựng đứng, kéo tay hoặc cho đi thử. Sau đánh giá và chỉ định, di chuyển bằng phương án an toàn phù hợp tổn thương và thiết bị. Ghi nhận diễn biến, tổn thương, xử trí và đáp ứng; báo cáo sự cố sau khi ưu tiên cứu chữa, phân tích hoàn cảnh và cập nhật kế hoạch để tránh tái diễn.

6.7 Kết thúc quy trình

Lượng giá kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ; kiểm tra điều kiện an toàn còn được duy trì, bàn giao việc chưa hoàn tất. Khi ra viện hoặc chuyển viện, cung cấp thông tin nguy cơ và hướng dẫn tiếp tục chăm sóc phù hợp; hồ sơ chuyển có nhận định, mức trợ giúp và sự cố liên quan. Phòng Điều dưỡng và Quản lý chất lượng tổng hợp kết quả theo kỳ để cải tiến.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

7.1 Trong khi thực hiện

Khi người bệnh chóng mặt, mất thăng bằng, giảm tỉnh táo hoặc bất thường trong di chuyển, dừng thao tác và trợ giúp về vị trí an toàn theo kỹ thuật đã đào tạo; không cố tiếp tục đi. Đánh giá và gọi hỗ trợ khi cần; báo bác sĩ để xử trí nguyên nhân. Nếu mắc kẹt ở thiết bị, gọi trợ giúp giải phóng an toàn, đánh giá tổn thương và ngừng sử dụng thiết bị lỗi cho đến khi kiểm tra.

7.2 Sau khi xảy ra té ngã

Đánh giá tri giác, hô hấp, tuần hoàn và chảy máu; theo dõi dấu hiệu sinh tồn theo tình trạng. Kiểm tra đau, biến dạng, khả năng vận động, tổn thương đầu và dấu hiệu

nghi cột sống trước di chuyển khi có thể. Không trì hoãn xử trí đe dọa tính mạng; bác sĩ chỉ định cận lâm sàng, điều trị và chuyển tuyến khi cần.

Báo ngay khi giảm tri giác, khó thở, co giật, yếu mới xuất hiện, đau đầu tăng, nôn, chảy máu, đau hoặc biến dạng nghi gãy xương. Ngã không có người chứng kiến hoặc không loại trừ chấn thương đầu cần bác sĩ đánh giá và quyết định theo dõi thần kinh. Cung cấp thông tin chống đông và chống kết tập; không kết luận an toàn chỉ vì không có vết thương ngoài hoặc người bệnh nói không đau.

Kế hoạch sau ngã ghi thời điểm và tần suất theo dõi, nội dung tri giác, đồng tử hoặc dấu hiệu thần kinh khi có chỉ định, dấu hiệu sinh tồn, đau và các ngưỡng gọi bác sĩ. Thời gian theo dõi tùy tình trạng và quy trình chấn thương; không tự đặt một lịch chung cho mọi trường hợp.

Báo điều dưỡng trưởng, bác sĩ và đầu mối quản lý sự cố. Ghi nhận mọi lần ngã dù chưa có tổn thương; tình huống suýt ngã ghi riêng. Đơn vị Quản lý chất lượng xác định phân loại, nội dung, thời hạn và nơi nhận báo cáo theo các quy định còn hiệu lực và quy trình hiện hành. Phiếu tường thuật trong phụ lục không thay mẫu báo cáo sự cố bắt buộc của bệnh viện.

7.3 Biến chứng muộn và phòng ngừa tái diễn

Theo dõi đau tăng, giảm vận động, biểu hiện thần kinh muộn và sợ vận động; đánh giá lại bởi bác sĩ khi xuất hiện. Phối hợp phục hồi chức năng và chăm sóc phù hợp. Giải thích dấu hiệu cần báo ngay, kể cả sau ra viện, theo tình trạng và hướng dẫn của bác sĩ.

Sau ổn định, khoa và Quản lý chất lượng rà soát điều kiện trước ngã, thuốc, trợ giúp, thiết bị, môi trường và việc thực hiện kế hoạch. Phân tích yếu tố hệ thống, giao hành động và kiểm tra hiệu quả; không quy toàn bộ nguyên nhân cho người bệnh “không tuân thủ”. Sự cố nghiêm trọng thực hiện phân tích và báo cáo theo quy định áp dụng.

Tài liệu tham khảo

1 QĐ 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023; đề cương và thể thức.

Bản 3023_QD-BYT_574343.pdf do người dùng cung cấp.

2 TT 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021; hoạt động điều dưỡng.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

3 TT 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013; quản lý chất lượng bệnh viện.

https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46963&Keyword=

4 TT 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018; phòng ngừa sự cố y khoa. CSDL ghi hết hiệu lực một phần; đối chiếu các nội dung còn hiệu lực trước ban hành.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=137205&Keyword=

5 QĐ 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016; Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0, D2.5.

https://soyte.laichau.gov.vn/upload/2000987/20221006/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

6 AHRQ Preventing Falls in Hospitals; phần 3 và công cụ 3H, 3N, 3O. Bảng Morse trang PDF 155.

https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications2/files/fallpxtoolkit-update.pdf

7 NICE NG249 ngày 29/4/2025; không dùng công cụ dự đoán đơn độc, đánh giá và quản lý toàn diện trong nhóm đối tượng hướng dẫn.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng249/chapter/Recommendations/

8 FDA A Guide to Bed Safety; lợi ích, nguy cơ thanh chắn và đánh giá cá thể hóa.

https://www.fda.gov/medical-devices/hospital-beds/guide-bed-safety-bed-rails-hospitals-nursing-homes-and-home-health-care-facts

9 NICE NG232; đánh giá chấn thương đầu, thông tin chống đông và dấu hiệu cảnh báo.

https://www.nice.org.uk/guidance/NG232/chapter/recommendations

10 Tài liệu nguồn được hoàn thiện.

QUY TRINH PHONG NGUA TE NGA 2026.docx

Tra cứu ngày 13/10/2026. Pháp chế hoặc Quản lý chất lượng đối chiếu phần hết hiệu lực của TT 43 và quy trình báo cáo đang áp dụng trước ký ban hành; tài liệu này không sao chép thời hạn báo cáo từ văn bản cũ khi chưa xác minh. Các hướng dẫn AHRQ, NICE và FDA là tham khảo chuyên môn, cần điều chỉnh theo phạm vi người bệnh và nguồn lực.

Phụ lục 1 Danh mục nguồn lực

Danh mục theo hình thức 4 cột của QĐ 3023. Số lượng thực tế phụ thuộc người bệnh và ca; không phải định mức áp dụng chung.

STT	Nguồn lực	Đơn vị	Số lượng và điều kiện
1	Điều dưỡng hoặc hộ sinh phụ trách	Người	1 người phụ trách; thêm hỗ trợ theo đánh giá
2	Bác sĩ và nhân viên phối hợp	Người	Theo nhu cầu và tình trạng
3	Thuốc phòng ngừa thường quy	—	Không có
4	Ký hiệu cảnh báo theo quy ước	Bộ	Theo người bệnh cần cảnh báo
5	Giày dép và vật dụng phù hợp	Bộ	Theo nhu cầu cá nhân
6	Giường băng ca hoặc xe lăn an toàn	Chiếc	Theo vị trí và phương án di chuyển
7	Chuông gọi hoặc phương tiện gọi khác	Bộ	Người bệnh tiếp cận và sử dụng được
8	Trợ cụ hoặc thiết bị chuyển người bệnh	Bộ	Theo chỉ định, tương thích và có người được đào tạo
9	Thiết bị đo và theo dõi	Bộ	Theo tình trạng và chỉ định

Phụ lục 2 Phiếu nhận định và kế hoạch phòng ngừa

Mã BM.ATNB.01 — đề xuất cập nhật. Họ tên và mã NB: ……; khoa: ……; ngày giờ: ……; người nhận định: ……

Lý do: □ Tiếp nhận □ Chuyển khoa □ Thay đổi tình trạng hoặc thuốc □ Sau thủ thuật □ Sau ngã hoặc suýt ngã □ Rà soát theo ca

Yếu tố đánh giá	Nhận định và nhu cầu hỗ trợ
Ngã trước đây và hoàn cảnh	……
Tri giác nhận thức và giao tiếp	……
Vận động thăng bằng và trợ cụ	……
Chóng mặt ngất và triệu chứng	……
Thuốc và thay đổi gần đây	……
Bài tiết thị giác và đau	……
Môi trường thiết bị và giày dép	……
Nguy cơ tổn thương khi ngã	……

Công cụ nếu dùng và phiên bản: ……; điểm: ……; kết luận lâm sàng: ……; lý do tăng hỗ trợ ngoài thang: ……

Yếu tố cần xử lý	Biện pháp mức hỗ trợ	Phụ trách và thời điểm
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……

Thời điểm đánh giá lại: ……; người bệnh hoặc người chăm sóc được hướng dẫn: ……; kiểm tra hiểu: ……; người nhận bàn giao: ……

Phụ lục 3 Morse khi được bệnh viện phê duyệt

Tóm tắt diễn giải tiếng Việt để kiểm tra điểm theo AHRQ 3H; bệnh viện thẩm định bản sử dụng và đào tạo cách chấm. Chỉ bổ trợ ở người lớn nội trú phù hợp. Không dùng tổng điểm để dự đoán chắc chắn hoặc loại trừ nguy cơ; không áp dụng mặc nhiên cho trẻ em, sản phụ hoặc ngoại trú.

Yếu tố	Lựa chọn và điểm	Điểm chọn
Tiền sử ngã	Không 0; có 25.	……
Chẩn đoán thứ hai	Dưới 2 chẩn đoán 0; từ 2 chẩn đoán 15.	……
Hỗ trợ đi lại	Không dùng, nằm nghỉ hoặc nhân viên hỗ trợ 0; nạng, gậy, khung 15; bám đồ đạc 30.	……
Điều trị đường tĩnh mạch hoặc khóa đường truyền	Không 0; có 20.	……
Dáng đi	Bình thường, nằm nghỉ hoặc xe lăn 0; yếu 10; suy giảm 20.	……
Nhận thức về khả năng	Biết giới hạn của mình 0; đánh giá quá khả năng hoặc quên giới hạn 15.	……

Chọn một mức mỗi yếu tố; tổng 0–125. Không cho đứng thử khi không an toàn. Dáng yếu và suy giảm phải quan sát phù hợp điều kiện; tình trạng không đánh giá được ghi rõ và quyết định hỗ trợ lâm sàng.

Ngưỡng đề xuất giữ để bệnh viện thẩm định: 0–24 thấp; 25–44 trung bình; từ 45 cao. Đây không phải ngưỡng của QĐ 3023. Bảng AHRQ 3H trình bày <25, 25–45, >45 và yêu cầu cơ sở tự xác định điểm cắt; một số chương trình AHRQ dùng ≥45. Vì vậy ngưỡng 45 trong bản nguồn cần được bệnh viện xác nhận, dùng thống nhất, không tuyên bố là một chuẩn bắt buộc duy nhất.

Ngày giờ: ……; người chấm: ……; yếu tố ngoài thang: ……; mức trợ giúp thực tế: ……; kế hoạch kèm theo: ……

Phụ lục 4 Theo dõi và bàn giao

Mã BM.ATNB.02 — đề xuất cập nhật. Họ tên và mã NB: ……; khoa: ……; kế hoạch phiên bản ngày: ……

Ngày giờ và ca	Tình trạng thay đổi	Biện pháp đã thực hiện và đáp ứng	Người làm và nhận
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

Bàn giao ISBAR: định danh ……; tình trạng ……; bối cảnh thuốc và lần ngã ……; nhận định vận động và nguy cơ ……; mức trợ giúp, việc cần làm và thời điểm ……

Phụ lục 5 Ghi nhận sau té ngã

Mã đề xuất BM.ATNB.03. Phiếu bổ trợ hồ sơ lâm sàng và phân tích; không thay mẫu báo cáo BM.QLCL.03 hoặc mẫu hiện hành của bệnh viện.

Họ tên và mã NB: ……; khoa: ……; ngày giờ xảy ra hoặc phát hiện: ……; người phát hiện và người chứng kiến: ……; địa điểm: ……

Nội dung	Ghi nhận
Hoạt động trước ngã và diễn biến	……
Ngã có người chứng kiến hay không	……
Ngã có hỗ trợ và bề mặt kết thúc	……
Đánh giá cấp cứu và sinh hiệu	……
Chấn thương đầu cột sống hoặc gãy xương nghi ngờ	……
Thuốc chống đông chống kết tập và bệnh liên quan	……
Gọi bác sĩ đội cấp cứu và thời điểm	……
Can thiệp chỉ định và đáp ứng	……
Lịch theo dõi và ngưỡng báo bác sĩ	……
Thông tin người bệnh người chăm sóc	……
Số báo cáo sự cố và người tiếp nhận	……
Nguyên nhân hoặc yếu tố góp phần	……
Kế hoạch cập nhật và bàn giao	……

Người ghi: ……; bác sĩ đánh giá: ……; đầu mối sự cố: ……; hành động và thời hạn kiểm tra lại: ……

Phụ lục 6 Bảng kiểm giám sát

Mã đề xuất BK.ATNB.01. Khoa: ……; ngày: ……; mã mẫu: ……; người giám sát: ……

STT	Tiêu chí	Đạt Chưa đạt KAD
1	Có nhận định và đánh giá lại theo thời điểm	……
2	Nhận định lâm sàng và yếu tố ngoài thang	……
3	Kế hoạch nêu mức trợ giúp và người phụ trách	……
4	Chuông gọi hoặc phương tiện khác sử dụng được	……
5	Môi trường giường và phanh phù hợp	……
6	Giày dép trợ cụ được kiểm tra	……
7	Hỗ trợ bài tiết và vận động theo kế hoạch	……
8	Cảnh báo đúng quy ước khi có chỉ định	……
9	Thanh chắn có đánh giá cá thể hóa nếu dùng	……
10	Người bệnh hoặc người chăm sóc hiểu hướng dẫn	……
11	Ghi thực hiện và bàn giao đủ thông tin	……
12	Sau ngã có đánh giá theo dõi và báo cáo phù hợp	……

KAD là không áp dụng, cần ghi lý do. Tiêu chí không có quan sát hoặc bằng chứng chưa được tính đạt. Lỗi cần khắc phục: ……; người phụ trách: ……; thời hạn: ……; kết quả kiểm tra lại: ……

Phụ lục 7 Chỉ số và lưu đồ

Phòng Điều dưỡng phối hợp Quản lý chất lượng thống nhất định nghĩa, nguồn và mục tiêu trước đo. Tổng hợp tháng, phân tích quý và giám sát đột xuất khi cần là lịch đề xuất nội bộ; không phải yêu cầu thời hạn chung của QĐ 3023.

Chỉ số	Công thức và quy tắc
Ngã nội trú	Số lần ngã nội trú / tổng ngày điều trị nội trú cùng kỳ ×1.000. Một người ngã nhiều lần tính đủ số lần; kể cả ngã có hỗ trợ.
Ngã có tổn thương	Số lần ngã nội trú gây tổn thương / tổng ngày điều trị nội trú cùng kỳ ×1.000. Phân loại mức độ theo hệ thống sự cố được duyệt.
Đánh giá đúng thời điểm	Số lần đánh giá hoặc đánh giá lại đúng lịch trong mẫu / tổng lần phải đánh giá trong mẫu ×100%.
Thực hiện kế hoạch phòng ngừa	Số trường hợp trong mẫu có biện pháp được chỉ định và thực hiện đầy đủ / tổng trường hợp hợp lệ được kiểm tra ×100%.
Cảnh báo khi có chỉ định	Số trường hợp cần cảnh báo có cảnh báo đúng quy ước / tổng trường hợp cần cảnh báo được kiểm tra ×100%. Không lấy toàn bộ NB làm mẫu số.
Báo cáo theo quy định	Số sự cố thuộc diện cần báo cáo đã báo đúng yêu cầu / tổng sự cố thuộc diện đó được phát hiện cùng kỳ ×100%. Xác định thời hạn theo quy định hiện hành.

Mẫu số 0 ghi không tính được hoặc không áp dụng và nêu lý do; dữ liệu thiếu không thay bằng 0. Ngã ngoại trú và ngã của người nhà theo dõi riêng với mẫu số phù hợp, không gộp vào ngày điều trị nội trú. Không coi số báo cáo giảm là bằng chứng ngã giảm nếu phát hiện và báo cáo chưa đầy đủ.

Lưu đồ thực hiện

Tiếp nhận hoặc thay đổi tình trạng → nhận định trước di chuyển → đánh giá yếu tố nguy cơ và nhu cầu trợ giúp.

Mọi người bệnh → biện pháp chung. Có yếu tố đáng lo → thêm kế hoạch hỗ trợ cá thể hóa, người phụ trách và lịch kiểm tra.

Thực hiện → ghi nhận và bàn giao → đánh giá lại theo ca hoặc ngay khi thay đổi.

Có té ngã → gọi hỗ trợ, đánh giá cấp cứu và chấn thương → xử trí, di chuyển an toàn theo tình trạng → theo dõi, ghi hồ sơ và báo cáo → phân tích và cập nhật kế hoạch.

Rà soát trước ban hành

Xác nhận mã và phiên bản, các nguồn pháp lý còn hiệu lực, đầu mối và yêu cầu báo cáo, bản công cụ theo đối tượng, ngưỡng Morse nếu giữ, ký hiệu cảnh báo, lịch đánh giá, nguồn lực và phương án hỗ trợ. Hội đồng chuyên môn thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt, đào tạo nhân viên và kiểm tra triển khai.

Thay đổi chính so với bản nguồn: sắp 7 phần và 5.1–5.9; sửa thang Morse và bỏ “0 điểm không có nguy cơ”; thêm mức trung bình và xác nhận ngưỡng; bổ sung nhận định toàn diện, hỗ trợ theo từng yếu tố, ngoại lệ nhóm chuyên khoa, thanh chắn an toàn, xử trí và theo dõi sau ngã, biểu mẫu và công thức chỉ số.